BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 9 novembre 2026

6 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · OptimPacing

Left Bundle-Branch Pacing versus Right Ventricular Pacing for Atrioventricular Block.

NEJM · 8 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé international, mené en ouvert, a comparé la stimulation de la branche gauche et la stimulation ventriculaire droite chez 685 patients ayant besoin d'une stimulation ventriculaire fréquente (bloc auriculoventriculaire ou fibrillation atriale lente et symptomatique) et dont la FEVG, le plus souvent normale, dépassait 35 %. Il a été arrêté avant son terme pour supériorité, après un suivi médian de 35,1 mois : le critère composite associant décès, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et cardiomyopathie induite par la stimulation est survenu chez 8,5 % des patients stimulés dans la branche gauche contre 19,2 % avec la stimulation ventriculaire droite (incidence cumulée à 4 ans ; HR 0,41 ; IC95 % 0,23–0,75 ; p = 0,003). La différence tient surtout à la cardiomyopathie induite par la stimulation, absente dans le groupe branche gauche (0 % contre 11,7 %), alors que la mortalité toutes causes a été voisine dans les deux groupes (7,4 % contre 7,7 %).

> **En pratique :** chez le patient qui a besoin d'une stimulation ventriculaire fréquente, pour un bloc auriculoventriculaire ou une fibrillation atriale lente, avec une FEVG supérieure à 35 %, cet essai randomisé de morbi-mortalité montre que la stimulation de la branche gauche réduit la survenue du critère composite par rapport à la stimulation ventriculaire droite, essentiellement en prévenant la cardiomyopathie induite par la stimulation ; la mortalité toutes causes a été voisine dans les deux groupes. Pour les investigateurs, la stimulation de la branche gauche devrait devenir le premier choix dans cette indication, et un autre essai randomisé publié peu avant dans le JAMA (LEAP-Block) allait dans le même sens. L'arrêt anticipé, le faible nombre d'événements, l'exclusion des FEVG altérées et l'emploi d'un seul type de sonde invitent à la prudence sur l'ampleur du bénéfice et sur sa transposition hors de la population et du matériel étudiés.

Article original · Communiqué AHA

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Suivi à long terme · ISCHEMIA-EXTEND

Long-Term Survival After Initial Invasive or Conservative Management of Stable Coronary Disease in ISCHEMIA-EXTEND.

JAMA · 7 novembre 2026 · Suivi à long terme · ISCHEMIA

Ce suivi prolongé de l'essai international ISCHEMIA a comparé la mortalité à long terme après une stratégie invasive d'emblée et après une stratégie conservatrice initiale chez 5 179 patients ayant une coronaropathie chronique avec ischémie modérée ou sévère. Après un suivi médian de 9 ans, la mortalité toutes causes à 11 ans n'était pas significativement différente : 25,8 % dans le groupe invasif contre 26,9 % dans le groupe conservateur (HR ajusté 0,97 ; IC95 % 0,86–1,09). La mortalité cardiovasculaire était de 15,8 % contre 17,1 % et la mortalité non cardiovasculaire de 9,1 % contre 8,1 %, deux différences non significatives. La survie moyenne restreinte à 11 ans ne différait que de 14 jours entre les deux stratégies (IC95 % −41 à 70 jours).

> **En pratique :** chez un patient ayant une coronaropathie chronique stable, avec ischémie modérée ou sévère, FEVG d'au moins 35 % et sans atteinte du tronc commun, une coronarographie suivie de revascularisation d'emblée n'a pas apporté de gain de survie démontré à 11 ans par rapport au traitement médical optimal avec geste invasif réservé à l'échec du traitement. Ce suivi prolongé conforte une stratégie conservatrice initiale chez ces patients lorsque l'objectif est la survie ; il ne renseigne ni sur les symptômes ni sur la qualité de vie, qui n'étaient pas ses critères de jugement. La tendance à moins de décès cardiovasculaires et à davantage de décès non cardiovasculaires dans le groupe invasif, non significative, ne modifie pas cette lecture.

Article original

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé de non-infériorité · STREAM

Discontinuing Statins in Older Adults without Cardiovascular Disease.

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité · AHA 2026

Cet essai randomisé de non-infériorité, en ouvert, a comparé l'arrêt et la poursuite de la statine chez 1 880 adultes de 70 ans et plus, porteurs d'au moins deux maladies chroniques, sans maladie athéroscléreuse connue et traités en prévention primaire depuis au moins un an. Sur le critère principal, qui réunit infarctus non fatal, AVC ischémique non fatal et décès, le temps moyen sans événement sur 2 ans a été de 96,5 semaines après l'arrêt contre 98,5 semaines en cas de poursuite, soit une différence de −2,0 semaines (IC95 % −3,7 à −0,3), un intervalle qui reste entièrement au-dessus de la marge de non-infériorité fixée à −5,2 semaines. Ce même intervalle ne contient toutefois pas zéro : les événements ont été plus fréquents après l'arrêt (12,7 % contre 9,2 % ; HR 1,38 ; IC95 % 1,05–1,81), soit, selon l'estimation présentée, un événement supplémentaire sur 2 ans pour 40 personnes qui arrêtent. La qualité de vie, les douleurs, les chutes et la sarcopénie n'ont pas différé entre les deux groupes.

> **En pratique :** chez un patient de 70 ans ou plus, polypathologique, sans maladie athéroscléreuse connue et sous statine en prévention primaire, l'arrêt du traitement est resté dans la marge de non-infériorité prédéfinie, mais il s'est accompagné d'un peu plus d'événements — infarctus, AVC ischémique ou décès —, de l'ordre d'un événement supplémentaire sur 2 ans pour 40 patients qui arrêtent. L'arrêt n'a par ailleurs rien changé de mesurable à la qualité de vie, aux douleurs, aux chutes ou à la sarcopénie. Ces résultats ne justifient donc pas un arrêt systématique, sans l'interdire chez un patient qui le souhaite : la décision se prend avec lui, en mettant ce petit surcroît de risque en balance avec la charge thérapeutique et ses préférences. L'écart a été plus marqué chez les participants recrutés en médecine générale (3,4 semaines contre 1,1) ; cette analyse de sous-groupe incite à une prudence particulière avant d'interrompre la statine d'un patient suivi en ville, sans valoir démonstration.

Article original · Analyse HCPLive

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé factoriel · Ez-PAVE

Statin-Ezetimibe Combination Therapy versus Statin Monotherapy in Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Prespecified Secondary Analysis of the Randomized Ez-PAVE Trial.

Circulation · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Dans l'essai Ez-PAVE, 3 048 patients atteints d'une maladie athéroscléreuse ont été randomisés deux fois, selon un plan factoriel : d'abord entre une cible de LDL-C inférieure à 55 mg/dL et une cible inférieure à 70 mg/dL, puis entre une association statine plus ézétimibe d'emblée et une statine seule. Le traitement était ensuite ajusté selon un protocole prédéfini pour atteindre la cible attribuée. Cette analyse secondaire préspécifiée porte sur la seconde randomisation. À 3 ans, 8,5 % des patients sous association d'emblée avaient présenté un décès cardiovasculaire, un infarctus, un AVC, une revascularisation ou une hospitalisation pour angor instable, contre 7,9 % sous statine seule, sans différence significative. L'association a abaissé davantage le LDL-C ; mais, selon la cible, un quart à un tiers des patients sous statine seule ont reçu de l'ézétimibe en cours de suivi pour atteindre la cible.

> **En pratique :** quand le LDL-C est surveillé et le traitement ajusté jusqu'à la cible, commencer par une statine seule et ajouter l'ézétimibe au besoin n'a pas conduit, à 3 ans, à davantage d'événements que l'association d'emblée, pour une sécurité comparable ; c'est l'atteinte de la cible qui semble compter, plus que le schéma de départ. L'association d'emblée a toutefois permis d'atteindre un LDL-C plus bas, et elle garde son intérêt quand une cible basse est visée. La comparaison n'était pas dimensionnée pour les événements cliniques : elle ne permet pas d'exclure une différence modeste entre les deux stratégies.

Article original · Analyse HCPLive

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE À connaître Essai randomisé en grappes · RACE-CARS

Community CPR and EMS intervention program did not increase survival after cardiac arrest (RACE-CARS)

NEJM · 8 novembre 2026 · Essai randomisé en grappes · AHA 2026

Cet essai pragmatique randomisé en grappes a comparé un programme communautaire d'amélioration de la réponse à l'arrêt cardiaque et l'organisation habituelle des secours dans 60 comtés de Caroline du Nord. Le programme associait la formation du public à la réanimation cardiopulmonaire, la formation des régulateurs des appels d'urgence à reconnaître l'arrêt cardiaque et à guider la réanimation par téléphone, et le renforcement de la défibrillation par les premiers intervenants. Chez les 22 459 adultes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier au cours des cinq années de l'étude, la survie à la sortie de l'hôpital avec une fonction cérébrale favorable a été d'environ 9 % dans les comtés du programme et de 9,4 % dans les comtés témoins, sans différence significative. La réanimation par un témoin a été un peu plus fréquente dans les comtés du programme (44,8 % contre 42,3 %), et, dans une analyse exploratoire de la dernière année, la cote de réanimation par un témoin (rapport de cotes) y était supérieure de 33 %.

> **En pratique :** ce grand essai randomisé en grappes ne montre pas qu'un programme communautaire associant formation du public à la RCP, régulation téléphonique renforcée et défibrillation par les premiers intervenants améliore, sur une période de cinq ans, la survie avec une bonne fonction cérébrale après un arrêt cardiaque extrahospitalier. Il ne porte pas sur l'efficacité de la RCP par un témoin ou de la défibrillation précoce prises isolément, mais sur la capacité d'un programme à les diffuser à l'échelle d'une population. Pour les investigateurs, la hausse tardive de la RCP par un témoin dans les comtés du programme suggère qu'un tel effort demande plus de temps pour modifier la réponse d'une communauté ; cette hypothèse reste à vérifier et les analyses détaillées sont attendues avec la publication.

Article original

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE À connaître Essai randomisé · DAPT-SHOCK-AMI

Cangrelor versus crushed ticagrelor in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (DAPT-SHOCK-AMI): a randomised, double-blind trial.

Lancet · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · ESC 2025

Cet essai randomisé en double aveugle, mené dans 29 hôpitaux de cinq pays européens, a comparé le cangrelor intraveineux et le ticagrelor écrasé chez 605 patients en choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde. À la fin de l'angioplastie primaire, une inhibition plaquettaire efficace a été obtenue chez 100 % des patients évalués sous cangrelor, contre 22 % sous ticagrelor écrasé. À 30 jours, le critère composite associant décès, infarctus et AVC ischémique est survenu chez 38 % des patients sous cangrelor et 41 % sous ticagrelor, sans que la non-infériorité du cangrelor soit démontrée (différence −4 points ; IC90 % −10 à 3 ; p de non-infériorité = 0,13). Les saignements majeurs à 30 jours ont concerné 6 % des patients sous cangrelor et 5 % sous ticagrelor.

> **En pratique :** dans le choc cardiogénique compliquant un infarctus, le cangrelor intraveineux obtient une inhibition plaquettaire efficace en fin d'angioplastie beaucoup plus souvent que le ticagrelor écrasé, sans que cet avantage biologique se traduise par une non-infériorité démontrée sur les décès, infarctus et AVC ischémiques à 30 jours. Les saignements majeurs ont été de fréquence voisine dans les deux groupes. Présenté comme le premier essai randomisé à comparer deux stratégies d'inhibition du P2Y12 dans cette situation, il ne permet de conclure ni à la supériorité ni à l'infériorité du cangrelor ; il n'impose pas de changer de stratégie et éclairera surtout la conception des essais à venir.

Article original · Résumé ACC.org

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.